

3

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO?

// DRA. VANINA STIER*

Médica Pediatra. Médica de planta Hospital Dr. Enrique Tornú.

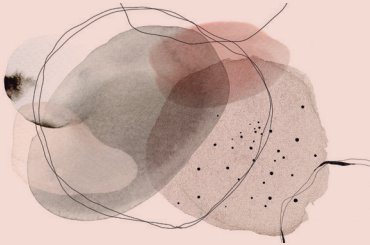
Integrante equipo Acompañamiento a las Crianzas.

Coautora de Familias, Crianzas, Equipos de salud - Encuentros posibles - Vol 3. 2023.

Sociedad Argentina de Pediatría.

Consultora Comité Nacional Pediatría General Ambulatoria.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



GABRIEL, 6 MESES

Gabriel concurre a control de salud mensualmente desde su nacimiento. Se trata de un RNPT 36 semanas con peso adecuado para edad gestacional (PEAG) PN 2.700g sin antecedentes perinataológicos. Actualmente tiene 6 meses y su familia está ansiosa por iniciar la alimentación complementaria. Han leído al respecto de la alimentación, pero dudan si ofrecerle los alimentos en papillas o con la técnica BLW. Su mamá María tiene temor a que se atragante y a no darse cuenta de si come lo suficiente. Gabriel recibe lactancia y fórmula de inicio cada 3 horas.

¿Qué aspectos evaluaría de Gabriel para indicar el inicio de la alimentación complementaria?
¿Qué recomienda respecto de la técnica alimentaria y ante los temores de su mamá?

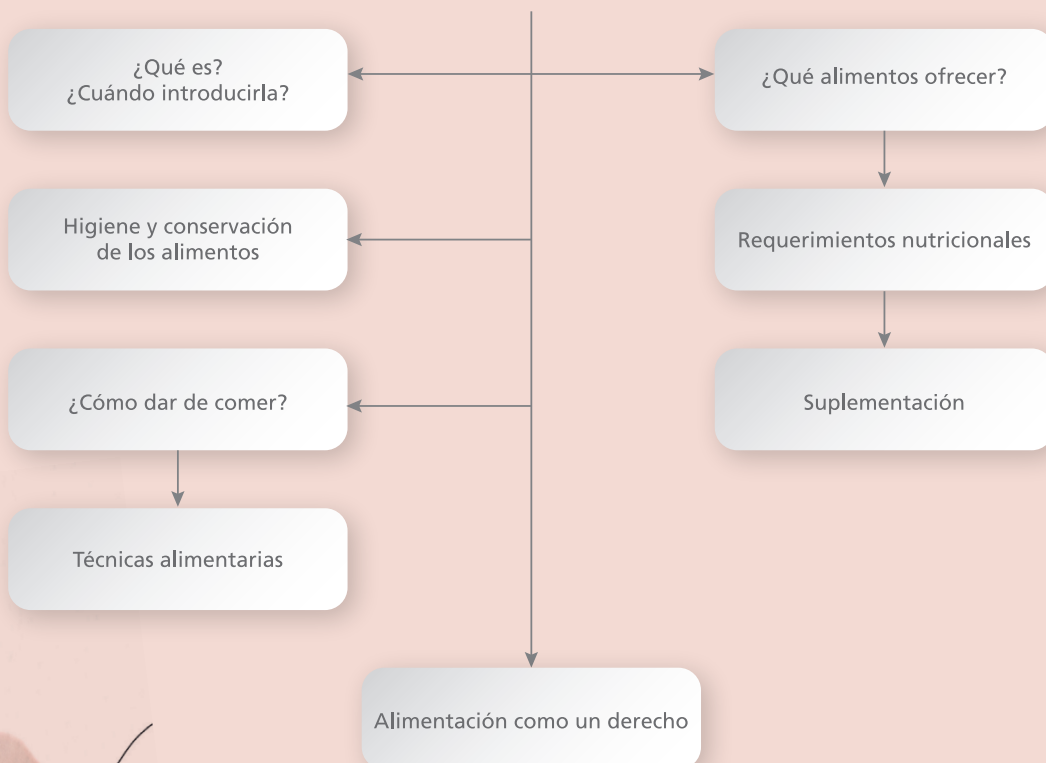


OBJETIVOS

- ◆ Contar con herramientas que permitan el acompañamiento a las familias en el inicio de la alimentación complementaria.
- ◆ Describir técnicas alimentarias.
- ◆ Promover hábitos alimentarios higiénicos y de alimentación saludable.
- ◆ Transmitir conceptos acerca de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.
- ◆ Potenciar la incorporación de alimentos regionales y de proximidad que favorezcan una dieta equilibrada y la identidad gastronómica local.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

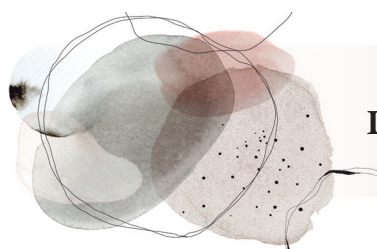
Alimentación complementaria ¿qué, cómo y cuándo?



INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo desarrollaremos la alimentación complementaria, sus inicios y su evolución. Nos proponemos pensar la alimentación complementaria como un proceso multidimensional y multifactorial que se encuentra fuertemente atravesado por las creencias, la cultura y los costumbres de las figuras de apego primordial y de su entorno.

La alimentación no es la mera incorporación de nutrientes, abarca los sabores, la creación del gusto y del paladar, la historia familiar y su relación con el momento de comer. La alimentación es con otras y otros.



La alimentación es en vincularidad.

Ese vínculo implica una relación con los alimentos y la comida, que depende fundamentalmente del adulto cuidador, que es quien los presenta. Con el alimento se incorporan nutrientes, afectos, cuidados y pertenencia a una familia y a una cultura.

El capítulo se centrará en el inicio de la alimentación complementaria de lactantes de término sanos. La alimentación complementaria óptima está relacionada no sólo con qué se come, sino también con el cómo, cuándo, dónde y quién alimenta al niño¹.

Podemos pensar a la alimentación complementaria como una puerta o ventana a través de la cual se presenta el mundo, el mundo de los nutrientes y la alimentación. Implica la existencia de un otro disponible para presentar, acompañar, explorar y permitir manipular aquello que es nuevo y diferente para el bebé y que requiere de un tiempo para su incorporación y aceptación. Este tiempo para algunos puede ser más y para otros menos.

Se desarrollarán también las nuevas tendencias en la alimentación, fundamentadas científicamente y considerando la fuerte impronta que tiene en la actualidad la información en medios y redes sociales. Las sugerencias se establecerán como una de las tantas posibilidades ya que cada pueblo, cada región y cada época tiene sus singularidades.

En este capítulo se considerarán varios aspectos para el proceso de acercamiento a la alimentación complementaria:

- ✓ Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para su inicio.
- ✓ Cuáles son los requisitos para su acompañamiento.
- ✓ Presentación de las distintas técnicas alimentarias.

1. Se utiliza en la escritura bebe, niño, niña a modo de simplificar, la misma incluye todas identidades y diversidades.

- ✓ Descripción de los requerimientos nutricionales.
- ✓ Hábitos alimentarios saludables.
- ✓ Formas de acompañar dietas no convencionales.
- ✓ Indicaciones y necesidades de suplementación.

Destacamos que en este recorrido la finalidad es el acercamiento a los alimentos en variedad y calidad de acuerdo a los requerimientos y necesidades en esta etapa de la vida.

¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y CUÁNDO INTRODUCIRLA?

Podemos definir a la alimentación complementaria como el conjunto de alimentos sólidos o líquidos que se ofrecen al bebé y se incorporan en forma oportuna, gradual y progresiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef recomiendan que la misma sea **a partir de los 6 meses de vida**. Se define esta edad por aspectos madurativos del bebe y porque la lactancia materna, además de favorecer la equidad y aportar enormes beneficios, cubre los requerimientos nutricionales hasta este momento.

En el caso de los niños prematuros se recomienda hacerlo de acuerdo a la edad corregida y cuando hayan alcanzado los hitos madurativos necesarios. En el caso de los niños no amamantados, si bien algunas sociedades plantean que la introducción puede realizarse entre los 4 y los 6 meses, desde la Sociedad Argentina de Pediatría recomendamos iniciarla a los 6 meses.

Nos encontramos dentro del periodo de los 1000 días, que abarca desde la concepción hasta los 2 años. Sin dudas es una etapa de oro y crítica, donde las acciones están orientadas a favorecer el adecuado crecimiento, desarrollo y maduración del bebe y a la prevención de patologías por carencia como la desnutrición, la malnutrición, la anemia ferropénica, así como también enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad. Estas últimas cada vez son más prevalentes en nuestra población.

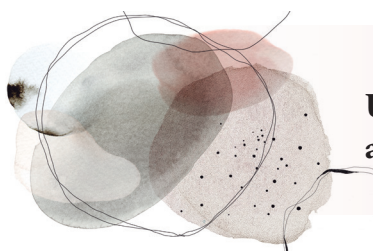
Acorde a la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud versión 2 (ENNyS-2)² realizada en nuestro país el bajo peso y la emaciación en el grupo poblacional de menores de 5 años fue del 1,7% y del 1,5% respectivamente, en cambio la proporción de sobrepeso alcanzó un 10%, con variaciones regionales. En cuanto al sobrepeso la Patagonia presentó un 15%, mayor al total nacional, y las regiones del NEA, NOA y Cuyo 7, 8,8 y 8,6% respectivamente. En cuanto a la obesidad la proporción fue de 3,6% para menores de 5 años, con algunas diferencias regionales.

Según se describe en la ENNyS 2 el 67,7% de las familias inicia la alimentación complementaria por indicación médica, seguido por la iniciativa familiar en un 25,7%.

2. Encuesta Nacional de Nutrición y salud versión 2 (ENNyS 2).

<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/2deg-encuesta-nacional-de-nutricion-y-salud-indicadores-priorizados>

Es parte de nuestra tarea de acompañamiento como pediatras y equipo de salud brindar información clara a quienes ejercen el cuidado de las niñas y los niños pequeños. Ello permitirá a las familias elegir lo más adecuado en etapas tempranas sensibles para lograr el óptimo crecimiento y desarrollo.



Una adecuada orientación va a sentar las bases de una alimentación saludable para la vida.

Hasta este momento el bebé, viene recibiendo lactancia materna o fórmula según cada situación individual. Ha llegado el momento de ofrecer y presentar alimentos según posibilidades y costumbres de cada grupo familiar.

Debemos observar distintos aspectos que deben darse en el bebé para reconocer que se encuentra madurativamente preparado para comenzar a comer. Ellos son:

- ✓ Que haya perdido el reflejo de protrusión lingual,
- ✓ Que pueda realizar trípodode o mantenerse sentado o erguido con soporte,
- ✓ Que tenga posibilidad de tomar alimentos con sus manos,
- ✓ Que demuestra interés y curiosidad por el mundo que lo rodea.

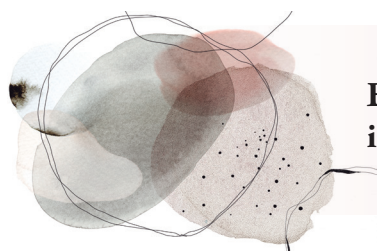
Reviste especial interés y trascendencia poder conversar con los adultos que ejercen el cuidado acerca de su posibilidad de estar disponibles, es decir que dispongan de tiempo real y emocional considerando que es un proceso que se irá estableciendo de forma paulatina.

Comer es un aprendizaje, que puede al principio generar aceptación total, parcial e inclusive rechazo. Podríamos definirlo como **“un arte”** donde habrá que desplegar habilidades y creatividad, donde será necesario ir probando distintas maneras de presentar un alimento hasta lograr su aceptación. Se establece una etapa inicial de exploración y conocimiento de aquello diferente que se presenta. Para el bebé es necesario tocar, explorar con sus manos el alimento, que es nuevo y diferente a lo que viene recibiendo. Es necesario transmitir a los cuidadores y figuras de apego³ que hay que dar tiempo, que reduzcan las expectativas respecto a lo que esperan de ese momento.

Es importante iniciar el proceso en algún momento del día que los cuidadores dispongan y lo reiteren rutinariamente durante la semana. Es decir, pueden ser los adultos los que elijan el horario para iniciar la alimentación. Es un momento de gran interrelación entre el bebé y los cuidadores. Los niños pequeños requieren que los miren, les hablen, los estimulen al momento de comer y se eviten los dispositivos como celulares, televisores o tablets acompañando este momento. Detenernos un tiempo en la consulta a conversar sobre este punto es fundamental.

3. Figura de apego: se utiliza este término para incluir a todas las maternidades, paternidades que ejercen la función de cuidado incluyendo la alimentación.

Como profesionales resulta importante pensar desde qué lugar proponemos y orientamos a quién nos consulta y nos pide sugerencias. Los cuidadores llegan a la consulta con preguntas, dudas e incertidumbres. Es importante conocer los orígenes de esa familia que acompañamos, sus costumbres en relación con el momento de alimentarse, preguntar si los cuidadores o figuras de apego ingieren todos los grupos de alimentos o si han elegido una alimentación en particular, saber si están dispuestos a presentar todos los grupos de alimentos y cuáles son sus creencias en torno a la comida. Es decir, conocer la historia en torno a la alimentación de ese grupo familiar. Es necesario también saber en qué lugar de la casa comen y quiénes participan de ello. Algunas preguntas que podemos realizar: ¿Se sientan en torno a una mesa?, ¿Quiénes participan del momento de la comida?, ¿Quién prepara o cocina los alimentos?, ¿Hay recetas transmitidas entre las distintas generaciones?, ¿Usan pantallas durante la comida?



El acto comer resulta una instancia intervicular, interrelacional, intergeneracional y es una instancia social.

Resulta fundante en la vida de los niños y niñas pequeños. Conocer el origen de cada familia, sus costumbres, la manera que tienen de elaborar o realizar las preparaciones nos permitirá acercarnos y tener un mayor entendimiento de lo que ofrecen y de cómo lo ofrecen. Debemos tener presente que las familias están expuestas a múltiples mensajes sobre alimentación que reciben del entorno, del equipo de salud, de lo que está de moda y actualmente de los medios y de las redes sociales. Como resultado de ese intercambio podremos acompañar y recomendar, siempre teniendo en cuenta lo que nos relatan, sus percepciones e interpretaciones. Es fundamental conocer los alimentos propios de cada región y el grado de accesibilidad que tiene cada una de las familias que acompañamos a los distintos alimentos, ya que no debemos recomendar algo que no puedan adquirir o no sea aceptable para ellos.

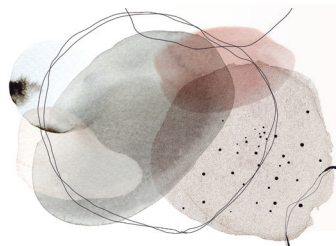
De esta manera podremos respetar, acompañar y optimizar nuestras recomendaciones, para introducir a los bebés en una alimentación variada, equilibrada, suficiente e individualizada con el fin de lograr su óptimo crecimiento y desarrollo.

¿QUÉ ALIMENTOS OFRECER Y CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES?

Llegamos al sexto mes y evaluaremos si el bebé ya está preparado para iniciar la alimentación complementaria. Hasta este momento puede encontrarse recibiendo lactancia materna exclusiva, alimentación mixta o fórmula. En nuestro país acorde al último informe ENaLac⁴ el 44,6% recibe lactancia materna exclusiva a los 6 meses.

4. Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Salud Perinatal y Niñez. "Situación de la Lactancia en Argentina. Encuesta Nacional de Lactancia, 2022". <https://iah.salud.gob.ar/doc/803.pdf>

Como es habitual, clasificaremos los alimentos por grupos y haremos consideraciones según cada caso, conociendo los alimentos locales y adecuándonos a la zona en la cual nos encontramos trabajando.



La lactancia materna, en los casos en los que se desea y haya posibilidad de continuarla, sigue siendo la mejor recomendación hasta los 2 años.

A través de ella los bebés reciben 35-40% del aporte energético diario. Es muy beneficioso cuando atraviesan una intercorriencia, ya que en general es el alimento que toleran y aceptan, además de mantenerlos hidratados. Por otra parte, brinda enormes beneficios a quien amamanta, disminuyendo el cáncer de ovario, de mama y la diabetes tipo 2.

La alimentación complementaria ayuda a cubrir los requerimientos nutricionales, favorece el desarrollo sensorial del bebé, transmite pautas y hábitos alimentarios saludables, promueve las conductas exploratorias y busca ir incorporando gradualmente al bebé a la comida familiar.

La alimentación complementaria aportará energía extra para cubrir las necesidades nutricionales a partir de los 6 meses. Este aporte es aproximadamente de 200 kcal al día entre los 6 y 8 meses, 300 kcal al día entre los 9 y 11 meses y 550 kcal al día entre los 12 y 23 meses de edad.

Se describen a continuación los distintos grupos de alimentos con breves comentarios de los nutrientes que aportan. Actualmente **no hay una secuencia específica sugerida para su introducción, lo importante es incorporar gradualmente todos los grupos de alimentos** acorde a las costumbres de la región.

✓ **Carnes.** Son fuente de proteínas de alto valor biológico, es decir que aportan aminoácidos esenciales. También son fuente de micronutrientes como hierro, zinc y vitamina B12.

Se recomienda que los niños reciban entre los 6 a 12 meses un 50% de proteínas de alto valor biológico, que son derivadas de fuentes animales y luego a partir de los 12 meses alcancen un 20-40%. El aporte promedio de proteínas que se recomienda es de 1g/kg/día entre los 6 y los 24 meses. Pueden ser carnes rojas o blancas y pescados, siempre magras. **Se desaconseja el consumo de carne picada** debido al riesgo de síndrome urémico hemolítico. El pescado debe ser sin espinas; no se encontró mayor incidencia de alergia o eccema atópico.

✓ **Frutas.** Se pueden ofrecer todas las que están disponibles según el lugar y la estación del año. Aportan sacarosa, agua, minerales y vitaminas, principalmente la vitamina C. No hay indicación de posponer aquellas que antes se consideraban alergizantes como el kiwi o la frutilla. Se deben ofrecer **sin el agregado de azúcares** de forma tal de asegurar que sea su sabor original. Los jugos de frutas no

ofrecen beneficios nutricionales sobre la fruta entera y en caso de ofrecerlos no deben superar los 120 ml diarios. Cabe aclarar que la ingesta de estos puede generar ganancia de peso inadecuada, tanto exagerada en algunos casos como insuficiente en otros por desplazar el consumo de otros alimentos. La recomendación es ofrecer la fruta entera sin semillas ni carozos.

- ✓ **Verduras.** Son fuentes de vitaminas, minerales y proteínas de menor valor biológico y menos digeribles. Se adecuan a cada zona según la disponibilidad. Se recomienda consumir con el agregado de aceites de oliva, maíz o girasol para aumentar la densidad energética y mejorar el sabor y la absorción de las vitaminas liposolubles que contienen. Quedan exceptuadas la espinaca, acelga, otras verduras de hoja y remolachas hasta los 9 meses por su contenido de nitritos, ya que pueden desencadenar metahemoglobinemia. En caso de decidir indicarlas se debe tener presente que no deben superar el 20% del plato. El grupo de los coles pueden producir flatulencia por lo que se evalúa la tolerancia en cada caso, si provoca incomodidad, se puede retrasar su introducción hasta los 9 meses. La introducción de verduras crudas se recomienda a partir de los 12 meses, siempre muy bien lavadas.
- ✓ **Cereales.** Aportan carbohidratos, minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales. Por lo general están suplementados con hierro y son fuente de energía. Se indican ofrecer aquellos cereales que no contienen azúcar agregada.
- ✓ **Legumbres.** Son fuentes de hidratos de carbono complejos, fibras, hierro y vitaminas del grupo B. Se recomienda dejarlas en remojo previo a su consumo, ofrecerlas muy bien cocidas, en distintas preparaciones en forma de untables, pisadas o machacadas para evitar el atragantamiento. Se desaconsejan las presentaciones en lata por el elevado contenido de sodio que presentan. Con respecto al poroto de soja, la alergia a la proteína de soja es de muy baja incidencia (0-0,5%).

Algunas consideraciones enunciadas en la Guía alimentaria NyN⁵

Huevo	Es fuente de proteínas, vitaminas, minerales y grasas esenciales. Puede ser incorporado desde los 6 meses de vida tanto la clara como la yema y no se ha demostrado aumento de alergia alimentaria por incorporación precoz. Puede ser utilizado en preparaciones o como alimento único. Debe lavarse y asegurarse la adecuada cocción, por el peligro de contaminación con Salmonelas.
Alimentos que contengan gluten TACC	Se recomienda su introducción en pequeñas cantidades en forma gradual y creciente desde los 6 meses. No se ha demostrado mayor riesgo de enfermedad celíaca y permite a las familias elegir una mayor variedad de alimentos para iniciar la alimentación complementaria.

5. Ministerio de Salud. Guías alimentarias de práctica clínica sobre alimentación complementaria en niños y niñas menores de 2 años, 2022.
<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-practica-clinica-sobre-alimentacion-complementaria-para-los-ninos-y-ninas-menores>

Lácteos y derivados	No se recomienda la oferta de lácteos durante el primer año. - La introducción de leche entera de vaca se recomienda luego de los 12 meses. En caso de no contar con otra opción, hasta el año deberá ser diluida 2/3 (es decir 2 partes de leche y 1 de agua) y enriquecida con aceite al 5% y azúcar al 2%. Según la OMS no se debe usar antes de los 9 meses ni en forma fluida ni reconstituida 12,5%, por la baja biodisponibilidad de hierro, la alta concentración de caseína y calcio, que disminuyen la absorción de hierro no hemínico y podrían producir anemia y finalmente, por la alta carga proteica para el riñón. Podría utilizarse en pequeñas cantidades para la preparación de los alimentos. Se desaconseja la leche descremada antes de los 2 años, es hipocalórica y pobre en vitaminas liposolubles. - Yogures: no debemos desconocer el riesgo de infección por E. Coli y la posibilidad de desarrollo síndrome urémico hemolítico por la ingesta de lácteos mal pasteurizados o que hayan perdido la cadena de frío. Si luego de los 12 meses se decide incorporarlos se recomienda que sean variedades con menos contenido de azúcar, sin colorantes y enteros. No se deben incluir los que tienen frutos secos, semillas o confites por riesgo de atragantamiento, tampoco los que contengan cereales azucarados. Por lo tanto, la recomendación es condicional. Los postres de leche caseros deben prepararse con leche acorde a la edad del niño, sin agregado de azúcares ni aditivos. No se recomienda ningún postre de leche comercial - Quesos: son fuente de calcio, proteínas, energía y vitaminas complejo B. también están recomendados en forma condicional según sus variedades. Las variedades duras y semiduras (reggianito, parmesano, sardo o provolone) contienen alto contenido de sodio, por lo cual solo se sugieren como condimento. Las variedades blandas o semiblandas tienen menor contenido de sodio y pueden ser incorporados según las preferencias de cada familia. Algo a tener en cuenta es su alto costo. Por lo anterior la recomendación es condicional.
-----------------------------------	--

La OMS recomienda que los lactantes empiecen a recibir alimentos complementarios a los 6 meses, primero unas 2 o 3 veces al día entre los 6 y los 8 meses y después, unas 3 o 4 veces al día, añadiéndoles una o dos colaciones nutritivas.

Otros aspectos a tener en cuenta:

- ✓ No agregar sal a los alimentos en menores de 1 año. Los alimentos contienen la cantidad de sodio que el aparato digestivo y renal pueden manejar en esta etapa.
- ✓ No agregar miel a la comida de los menores de 12 meses debido al riesgo de botulismo.
- ✓ Evitar los alimentos que puedan hacer que los niños se atoren: maníes, frutos secos, aceitunas, uvas enteras, zanahoria cruda, semillas.
- ✓ No agregar azúcares a la alimentación complementaria.
- ✓ Si bien puede existir preferencia por algunos sabores, transmitir a las familias que la alimentación debe ser variada y que no deben desalentarse ante el rechazo de

algún alimento por parte del lactante. Ofrecerlo varias veces.

- ✓ Desaconsejar la ingesta de mate o de té por porque disminuye la absorción del hierro y por el riesgo de intoxicaciones.
- ✓ Transmitir siempre el concepto de alimentación saludable como base de alimentación desde la incorporación de la alimentación complementaria, evitando el exceso de sal y azúcar y los ultraprocesados.

AGUA. Alimento líquido fundamental para mantenerse hidratados. **Los bebés no requieren otro tipo de líquido.** Debemos asegurarnos de que sea potable y segura. En caso de no contar con ello, indicar maneras de potabilizar la misma. Puede ser:

- a) Agregando 2 gotas de lavandina (apta para desinfectar agua) por litro de agua y dejar reposar durante 30 minutos. Colocar tapa mientras reposa hasta que se enfría.
- b) **Hervir por 3 minutos** y dejar reposar hasta que se enfríe.

En el caso de que nos consulten por agua mineral recomendar la que sea baja en sodio. Ofrecer la misma luego de la ingesta de sólidos, pudiendo darse la misma en un vaso común o en una taza.

HIGIENE Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Es necesario dedicar un tiempo en la consulta a conversar sobre la adecuada higiene de los alimentos, separando los crudos de los cocidos. Se deben utilizar utensilios y tablas diferentes para la manipulación de estos.

Es importante recomendar el lavado adecuado, utilizando agua segura y la adecuada cocción, ello es fundamental con carnes, vísceras y huevos (lavado estricto previa cocción).

La conservación debe hacerse a 4 °C y la cocción mayor a 60 °C para el consumo. De esta manera lograremos evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Debemos tener presente que las enfermedades causadas por patógenos contaminantes de los alimentos son causa de morbilidad elevada en la infancia.

¿CÓMO DAR DE COMER?

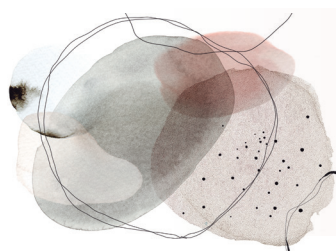
Si partimos de la premisa de que el objetivo que buscamos es la incorporación y la aceptación de los distintos grupos de alimentos en su totalidad, podremos transmitir a las familias que, si bien **hay distintas técnicas alimentarias**, no hay una mejor que otra. Podríamos definirlas como complementarias.

Se puede optar por ofrecer semisólidos con cuchara o pisados, o en pequeños trozos que el bebé tome con sus manos, técnica conocida como BLW (Baby Led Weaning). Las mismas permitirán presentar los alimentos en sus distintas formas, sabores, colores y texturas. Ambas técnicas se pueden complementar, hay bebés que prefieren las papillas y otros los trozos. La finalidad del proceso

es que el niño acepte e incorpore paulatinamente todos los grupos de alimentos. Se propone la introducción gradual y progresiva de los distintos grupos, inicialmente en una o dos comidas al día. En la medida en que la incorporación de alimentos es placentera y se observa aceptación se van agregando las distintas comidas del día, inicialmente desplazando el horario del pecho o la fórmula, pero sin reemplazarlas.

La exposición sostenida y reiterada a los alimentos en sus diferentes presentaciones, texturas, colores y sabores va generando su aceptación. De esta forma se construyen el gusto y el paladar. Él bebé debe transitar este proceso desde lo lúdico y en interrelación vincular. Para dar de comer cada familia deberá evaluar con cada alimento que técnica resulta más confortable y tiene mayor aceptación por parte del bebé.

Técnicas alimentarias



Se refuerza la idea de que las técnicas pueden ser complementarias y sin fundamentalismos en su elección, adecuarse a cada situación particular.

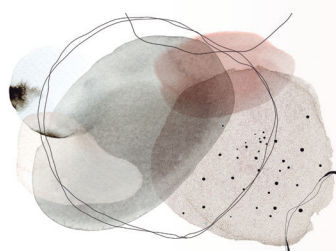
Papillas	Implica pisar o desmenuzar alimentos. Pueden ser enriquecidos con agregado de aceites que pueden ser de oliva, maíz o coco. Se recomienda evitar el uso de procesadoras o licuadoras, así el bebé aprende a aceptar distintas texturas y consistencias.
BLW (Baby Led Weaning)	Es la técnica de alimentación complementaria, autorregulada por el bebé, en trozos. Requiere que el bebé haya adquirido la sedestación. Implica su participación, con supervisión, pero sin intervención de los adultos. Es decir que tenga inquietud por los alimentos, explore, juegue, pueda tomarlos con sus manos y llevarlos a la boca. Esta forma de alimentación propone una mayor autorregulación de la ingesta. Los alimentos deben ser de consistencia blanda de forma tal que, al ser llevados a la boca, el bebé pueda aplastarlos con sus encías y su lengua. Este método propone además incorporar al bebé a la mesa familiar desde el inicio, sin necesidad de preparar otros alimentos diferentes al resto del grupo familiar.
BLISS (Baby led introduction to solids)	Esta técnica surge en Nueva Zelanda, en el año 2015, a partir de la preocupación de los profesionales, modificando el BLW con la introducción de alimentos que contienen mayor cantidad de hierro y energía. Los alimentos con alta cantidad de hierro que se priorizan son las carnes (roja, pollo, pescado) y las legumbres (lentejas, porotos). Alimentos que contienen alta energía: palta, banana, papa, batata.

Debemos enfatizar que, en el momento de la comida, los bebés y niños pequeños requieren supervisión siempre. Suele aparecer en las consultas el temor o riesgo de atragantamiento. No hay evidencia que indique que con la técnica de BLW o BLISS los niños tengan más posibilidad de atragantamiento. Lo importante es transmitir que no deben quedar solos al momento de alimentarse y que requieren siempre la presencia del adulto.

Otro concepto para transmitir es el de **alimentación perceptiva**. El mismo tiene que ver con la capacidad del adulto cuidador de transmitir placenteramente lo que significa comer, con una mirada atenta, con posibilidad de escucha y decodificación de las señales que transmite el niño pequeño al momento de comer. En este modelo de alimentación perceptiva se propone un adulto responsable que guíe en el momento de comer, con refuerzos positivos y estableciendo límites necesarios. También implica tener presente y aceptar la capacidad de las niñas y los niños pequeños de autorregulación de la ingesta, es decir de momentos de hambre y otros de saciedad. La idea principal es centrarse en ofrecer variedad acorde a la disponibilidad local transmitiendo hábitos saludables, **sin interferir en la cantidad de comida**.

Es esencial hacer hincapié en que no dejen a los niños con dispositivos electrónicos que los distraigan o los lleven a perder interés en lo que se les está proponiendo. Por otra parte, se aconseja **ofrecer entre 8 y 10 veces un alimento antes de definir que el mismo es rechazado**.

El momento de la comida es “con y junto” a otros. Idealmente es un espacio de cuidado. Al incorporar la alimentación complementaria, la propuesta es que los niños y niñas pequeños puedan ser integrados en la mesa familiar y compartan con su núcleo el momento de la comida. Como se menciona al comienzo del capítulo, es la introducción de las infancias a la cultura a la que pertenecen.



También es un momento en el que se pueden desplegar conductas de maltrato o violencia. La comida no debe ser utilizada como premio o castigo. Estas situaciones deben ser evaluadas en la consulta y detectadas tempranamente para poder intervenir.

SELECTIVIDAD ALIMENTARIA – NEOFOBIA

“No come nada o no prueba nada”

Seguramente en nuestra práctica en más de alguna oportunidad, hayamos escuchado esta frase. Reviste especial importancia conversar con las familias que algunos niños y niñas pequeñas, en general menores de 3 años, pueden presentar neofobia alimentaria. Es el rechazo de alimentos nuevos o desconocidos.

Es fundamental estar atentos, con escucha ampliada a lo que las familias nos refieren. Puede ser

que no demos importancia porque evaluamos que el crecimiento ponderoestatural es adecuado, pero suele ser un motivo de preocupación para los cuidadores y dificulta el momento de la alimentación. Ello conlleva momentos de tensión familiar importante a la hora de comer.

Una de las maneras de resolverlo puede ser la exposición reiterada en diferentes presentaciones o texturas de ese alimento que se rechaza. Como se mencionó antes, hay que presentarlo por lo menos entre 8 y 10 veces. Cabe aclararles a las familias que con el inicio de la deambulaci3n las ni1as y ni1os peque1os pueden perder inter3s en el momento de comer, pasan a estar m3s interesados por explorar y conocer el mundo y el tiempo destinado a comer o la permanencia en el lugar designado para hacerlo ya no es tal.

Las dificultades en la alimentaci3n son sumamente frecuentes, con participaci3n de rasgos propios del ni1o o ni1a, del medio ambiente y de la familia. Requiere especial atenci3n si el ni1o tose al momento de alimentarse, si presenta arcadas o v3mitos o si aparece retraso en la progresi3n ponderoestatural. Las causas son variadas y pueden requerir tratamiento espec3fico.

Otro aspecto a tener presente es el **picoteo**. Puede ocurrir debido a que los adultos lo ofrecen o porque el ni1o o ni1a lo demanda. En muchas ocasiones la comida es ofrecida por fuera de los momentos de alimentaci3n familiar, lo cual va generando saciedad. Como consecuencia los ni1os llegan al momento de la comida con menos apetito. Esto lleva a la percepci3n de que “comen poco”. Evaluar si hay sobreoferta de alimentos en forma continua nos permitir3 orientar y conversar preventivamente con las familias. De esta manera podremos abordar estas situaciones cuando se presentan y definir estrategias a seguir seg3n cada caso.

SUPLEMENTACI3N

- ✓ **Vitamina D.** La vitamina D interviene en el metabolismo fosforoc3lcico y tiene otras funciones en diversos 3rganos. Su d3ficit se asocia fundamentalmente a raquitismo y osteomalacia. Su principal fuente es la s3ntesis cut3nea a partir de la exposici3n solar directa, tambi3n la podemos encontrar en algunos alimentos como los pescados, la yema de huevo y algunos productos fortificados como cereales o leches. La suplementaci3n con vitamina D en lactantes RNT alimentados con leche humana se inicia a los 2 meses y es necesario continuarla hasta los 12 meses debido a que los ni1os peque1os no deben tener exposici3n directa a la luz solar. Los requerimientos son de 400 UI/d3a.
- ✓ **Hierro.** Es sabido que se trata de la principal carencia nutricional de ni1as y ni1os peque1os en la Rep3blica Argentina. Si bien en la leche humana la cantidad de hierro es baja, el mismo tiene una alta biodisponibilidad por lo cual en ni1os amamantados, con clampeo oportuno de cord3n, los requerimientos nutricionales se cubren hasta los 6 meses. A partir del sexto mes, se recomienda el aporte suplementario de sulfato ferroso 1mg/kg/d3a (RNT PAEG). En caso de que existan facto-

res de riesgo, como bajo peso o clampeo precoz de cordón, la suplementación se indicará antes, a los 4 meses. En caso de prematurez, el hierro será indicado entre las 2 a 4 semanas de vida y se adecuará al peso de nacimiento. El hierro debe ser aportado solo, en caso de rechazo se puede administrar con jugo cítrico natural que contiene vitamina C y favorece su absorción.

ALIMENTACIÓN BASADA EN PLANTAS

En nuestra práctica podemos encontrarnos con familias que nos planteen que llevan adelante una alimentación vegetariana, vegana o basada en plantas. Este tipo de alimentación requiere planificación y supervisión.

Es necesario conocer la clasificación existente ⁶	
Vegana	Excluye todos los alimentos de origen animal y sus derivados (lácteos, huevos y miel). El veganismo excluye todo uso de animales en cualquier forma, involucrando mucho más que la alimentación, consolidándose como un posicionamiento ético y político.
Ovo vegetariana	Alimentos de origen vegetal y huevos.
Lactovegetariana	Alimentos de origen vegetal que incluye también lácteos y derivados (leche, yogur, queso, manteca, crema).
Lactoovovegetariana	Incluye alimentos de origen vegetal, huevos, lácteos y derivados.
Flexitariana	También denominada alimentación vegetariana flexible. Excluye carnes de forma habitual, pero las incluye de manera ocasional, como una situación social.
Crudivegana	Alimentación de origen vegetal en la que 75 a 100% de los alimentos son consumidos crudos: verduras, frutas frescas, frutos secos, semillas, brotes, entre otros.
Frugívora o fructariana	Incluye exclusivamente frutos, generalmente crudos y de época: fruta, frutos secos, semillas y otros componentes que pueden ser recogidos sin dañar la planta.

Excede las posibilidades del capítulo describir detalladamente cada una de ellas. Sin dudas será un gran desafío para muchos, ya que, la recomendación es orientar a las familias para que se cubran los requerimientos energéticos y los de los nutrientes esenciales de esta etapa y posteriormente en la infancia y adolescencia. Se enumeran alguno de ellos calcio, hierro, zinc, proteínas, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3 y vitamina B12.

6. Ministerio de Salud de la Nación. Documento de revisión sobre Alimentación Basada en Plantas, Vegetariana y Vegana. Argentina. 2023. <https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2023-12/documento-revision-sobre-alimentacion-basada-en-plantas-vegetariana-vegana-dic-2023.pdf>

La vitamina B12 es una coenzima clave en la síntesis de ADN y la maduración celular, como así también en la síntesis de lípidos neuronales. Su principal fuente son las carnes, huevos, leche y derivados, por lo cual las personas que no los ingieren deben recibir suplementación. Cabe recordar que aquellas personas que llevan una alimentación basada en plantas y se encuentran amamantando deben realizar controles de laboratorio a fin de establecer si sus niveles de vitamina B12 son adecuados, más allá de estar suplementadas, ya que muchas veces nos encontramos con que se agotan sus reservas. Si la madre tiene niveles adecuados, a partir de los 6 meses se debe iniciar la suplementación en el bebé. Los síntomas por deficiencia de B12 son la apatía, irritabilidad, falla de crecimiento, anemia megaloblástica, hipotonía y retraso en el desarrollo. Una vez instalados, el daño neurológico y el déficit cognitivo son irreversibles. Se debe conversar y acordar con las familias la necesidad de controles de laboratorio periódicos y suplementación. Acorde a los niveles dosados se establecerá el requerimiento y cantidad de vitamina B12 a indicar.

En el caso de las familias veganas cuyos bebés requieren suplementación, la fórmula que se indica en este tipo de alimentación es la fórmula de soja.

Esta forma de alimentación suele aportar adecuados niveles de omega 6 pero son deficitarias en omega 3, también nutriente crítico que favorece el desarrollo cerebral.

Por lo cual, ante esta elección de alimentación se sugiere consulta con pediatra especialista en nutrición a fin de realizar la planificación adecuada, garantizando que se cubran los distintos requerimientos.

Bibliografía: Comité Nacional de Nutrición. Dietas vegetarianas en la infancia. Arch Argent Pediatr 2020; 118(4):S130-S141. https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_dietas-vegetarianas-en-la-infancia-108.pdf

ALIMENTACIÓN COMO UN DERECHO

Es nuestra tarea acercar a las familias las herramientas para lograr el objetivo de que la alimentación sea amplia, variada, saludable, sustentable y se pueda sostener en el tiempo.

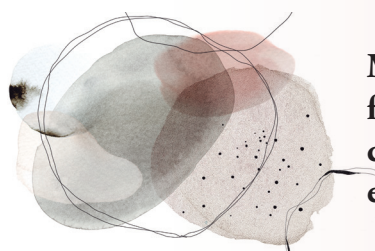
Hablar de Derecho a la Alimentación o la alimentación como un derecho refiere a la posibilidad de tener acceso a la misma sin interrupciones. A partir de su autoproducción o de la compra a alimentos en cantidad suficiente, calidad adecuada y de acuerdo con la cultura y tradiciones de la población, como para garantizar a las personas y a las próximas generaciones, no sólo a nivel individual, sino también colectivo, una vida plena y digna. Garantizar el pleno derecho a una alimentación saludable para toda la población argentina es una tarea del Estado.

Recientemente, fue sancionada la Ley 27.642 en noviembre de 2021. Es conocida como Ley de alimentación saludable o de etiquetado frontal. La ley establece la obligación de colocar sellos de advertencia en la cara frontal de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas que presenten exceso de nutrientes críticos. Estas leyendas pueden expresarse como:

- ✓ “Exceso de sodio”.
- ✓ “Exceso de azúcares”.
- ✓ “Exceso de grasas saturadas”.
- ✓ “Exceso de grasas totales” y/o “Exceso de calorías”.

A su vez, aquellos productos que contengan edulcorantes y/o cafeína deberán contener una leyenda precautoria que indique: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” y/o “Contiene cafeína, evitar en niños/as”.

La ley aplica para alimentos envasados en ausencia del cliente; por lo tanto, no alcanza a productos provenientes de fiambrería o panadería fraccionados frente al cliente. Asimismo, la ley regula la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, de alimentos y bebidas alcohólicas envasados que contengan algún sello de advertencia, en medios de comunicación masiva, y en los envases, así como la promoción y el patrocinio de esos productos. En este sentido, se promueve la educación alimentaria.



Mencionar y trabajar este aspecto en las consultas con las familias se hace necesario desde el inicio de la alimentación complementaria para que puedan conocer lo que contienen en las etiquetas los diferentes productos que se adquieren.

Los niños y niñas pequeños suelen ser el blanco de mucha publicidad alimentaria independientemente del nivel socioeconómico o educativo de los cuidadores. Es recomendable dedicar un tiempo en la consulta al inicio de la alimentación para explicar a las familias y hablar al respecto de los distintos tipos de alimentos disponibles en el mercado. La base de la alimentación saludable es un pilar fundamental para asegurar un óptimo crecimiento y desarrollo y la cobertura de los nutrientes esenciales.

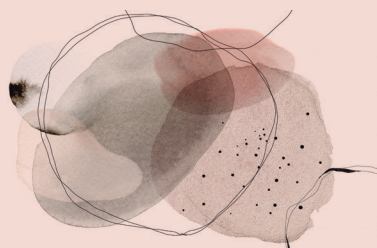
Actualmente con el pluriempleo, el tiempo que implica la preparación y producción de la comida en muchos hogares se tiende al consumo de ultraprocesados lo cual no se recomienda en la infancia.

Los alimentos ultraprocesados se producen combinando ingredientes procesados con cantidades frecuentemente pequeñas de alimentos sin procesar o mínimamente procesados.

Se les agrega ingredientes industriales con alto contenido de grasas, azúcares y/o sal, así como aditivos alimentarios (conservantes, colorantes, aromatizantes, etc.). Son productos que no deberían formar parte de nuestra alimentación diaria ya que su consumo en exceso puede dañar la salud, aumentando el riesgo que aparezcan condiciones de salud como la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, entre otras. Ejemplos: gaseosas, aguas saborizadas, jugos de fruta endulzados, bebidas energizantes y deportivas, postres lácteos, panes industriales, productos de copetín o snacks, comidas listas para consumir, productos preformados congelados

como bastones de merluza, carnes procesadas como salchichas, aderezos, salsas listas para consumir, leche chocolatada entre otros. Sin dudas no recomendamos este grupo de alimentos en la primera infancia.

Reforzamos la idea que es necesario transmitir, trabajar y conversar con las familias estos conceptos de forma tal que desde los inicios conozcan la ley vigente y puedan elegir y decidir que ofrecer a las infancias. Los alimentos ultraprocesados constituyen una de las batallas más intensas a las que nos enfrentamos los y las pediatras diariamente. Es desde etapas muy tempranas que estos temas deben incluirse en cada encuentro con las familias. Es fundamental empoderarlas y darles a conocer estos aspectos, que sin dudas son claves al momento de elegir que ofrecer a los niños y niñas pequeños.



Autoevaluación

I. Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados.

	V	F
1. En nuestro país según la ENaLac menos del 45% de los niños y las niñas recibe lactancia materna exclusiva a los 6 meses.	☐	☐
2. El aporte de energía de la alimentación complementaria es aproximadamente de 200 kcal al día entre los 6 y 8 meses, 300 kcal al día entre los 9 y 11 meses y 550 kcal al día entre los 12 y 23 meses de edad.	☐	☐
3. Se recomienda la introducción paulatina de todas las verduras a partir de los 6 meses.	☐	☐
4. El huevo, lavado y bien cocido, puede ser incorporado desde los 6 meses de vida tanto la clara como la yema.	☐	☐
5. La recomendación de la OMS en relación con la frecuencia de la alimentación entre los 6 y los 8 meses es 2 o 3 veces al día y después, unas 3 o 4 veces al día, añadiéndoles una o dos colaciones nutritivas.	☐	☐
6. Entre las recomendaciones se encuentran no agregar sal, azúcar ni miel a los menores de 12 meses.	☐	☐
7. Las diferentes técnicas alimentarias pueden ser complementarias y sin fundamentalismos en su elección, adecuarse a cada situación particular.	☐	☐
8. La técnica BLW (Baby Led Weaning) propone la introducción de alimentos que contienen mayor cantidad de hierro y energía.	☐	☐
9. En el momento de la comida, los bebés y niños pequeños requieren supervisión siempre, independientemente de la técnica de alimentación que se utilice.	☐	☐
10. Conocer la historia alimentaria de cada familia permitirá un mejor acercamiento a costumbres, tradiciones y a comprender elecciones que se realizan en torno a la alimentación y al momento de la comida.	☐	☐

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

1. GABRIEL, 6 MESES

Vuelva a leer el relato de Gabriel del principio del capítulo y responda.

A. ¿Qué aspectos evaluaría de Gabriel para indicar el inicio de la alimentación complementaria?

.....

.....

.....

B. ¿Qué recomienda respecto de la técnica alimentaria y ante los temores de su mamá?

.....

.....

.....

2. LUNA, 9 MESES

Concurren a su consultorio para control de salud Luna con sus padres, Diana y Sebastián. Se trata de una RNT PAEG (40 semanas -PN 3980 g) Nacimiento por cesárea por falta de progresión de trabajo de parto. Refieren internación en neonatología por hiperbilirrubinemia, permaneció en luminoterapia 2 días. Presenta maduración acorde edad. Respecto de su alimentación recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en el cual le indican la incorporación de alimentación complementaria. Refieren que al ofrecer los alimentos Luna los toma con la mano, los lleva a la boca, pero en general es “poco” lo que acepta. Hasta ahora ha probado puré y banana. La mama prefiere ofrecerle el pecho dado que según refiere: “Es más sencillo y hacemos más rápido”.

Luna presenta buena progresión pondoestatural. Examen físico dentro de parámetros normales. No recibe suplementos.

A. ¿Qué piensa de la alimentación de Luna?

.....

.....

.....

B. ¿Qué orientación o recomendaciones le daría a la familia?

.....

.....

.....

C. ¿Indica algún suplemento?

.....

.....

.....

3. HELENA, 18 MESES

Concurre a la consulta Helena acompañada por Martiniano, su papá y Andrea la mamá. Se trata de una RNT PAEG (40 semanas PN 3.140 g y Talla: 47 cm PC 34 cm) sin antecedentes perinatológicos a destacar. Recibió lactancia materna exclusiva hasta el tercer mes y luego por decisión materna agregaron fórmula de inicio. Presenta desarrollo madurativo acorde a edad. A los 6 meses le indicaron incorporar alimentación complementaria. Sus padres consultan preocupados porque Helena comenzó a rechazar alimentos que antes comía con ganas, selecciona y separa del plato lo que le ofrecen, en general las carnes y las arroja al piso y además refieren que come poco. Por otra parte, relatan que solo con el acompañamiento de la televisión o algún otro dispositivo electrónico come mejor. Actualmente Helena se encuentra en buen estado general sin datos relevantes al examen físico.

A. ¿Qué datos profundizaría en la consulta?

.....

.....

.....

B. ¿Qué recomendaciones haría a la familia?

.....

.....

.....

C. ¿Qué diría de los dispositivos electrónicos al momento de la ingesta?

.....

.....

.....

CONCLUSIONES

Acompañar el proceso de inicio de alimentación complementaria es una tarea que nos convoca diariamente. Conocer la historia alimentaria de cada familia nos permitirá un mejor acercamiento a costumbres, tradiciones y a comprender elecciones que se realizan en torno a la alimentación y al momento de la comida. Como ya mencionamos aprender a comer lleva tiempo, dedicación, preparación, disposición por parte de los adultos cuidadores para poder presentar a los niños y niñas pequeñas la alimentación complementaria.

Para ello debemos

- ✓ Fomentar la identificación, el descubrimiento y la aceptación progresiva de los diferentes alimentos.
- ✓ Promover, al momento de incorporar la alimentación complementaria, la continuidad de la lactancia materna, en los casos en que se lo desea, hasta los 2 años.
- ✓ Promover hábitos higiénicos alimentarios adecuados teniendo en cuenta los aspectos sociales, de época y las costumbres de cada familia.
- ✓ Potenciar la variedad y la identidad gastronómica de la zona, incorporando alimentos de temporada, locales y de proximidad.
- ✓ Dedicar tiempo en la consulta a conversar sobre el momento de la comida e insistir en evitar pantallas o dispositivos electrónicos acompañantes.
- ✓ Proponer pensar junto a las familias que se elige, cómo y por qué.
- ✓ Dedicar un tiempo a comentar sobre sellos nutricionales de los alimentos y alcances e implicancias de la alimentación saludable.
- ✓ Pensarla como una construcción atravesada por múltiples condicionantes.
- ✓ Pensar la alimentación desde una perspectiva de derechos.

La alimentación es un momento de intercambio y de encuentro. Es necesario retomar los distintos aspectos o variables de ésta para acompañar a las familias. Es un momento de encuentro con la diversidad, lo cual permitirá ampliar y enriquecer el vínculo equipo de salud-familias.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Guía de Práctica Clínica sobre Alimentación Complementaria en niños y niñas menores de 2 años - Msal 2022
<https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2022-03/guia-alimentaria-nyn-2022>
- Pronap Nutricion - módulo 2-2020: Alimentación y Cultura. Dra. Patricia Aguirre y Dra. Noemi D'artagnan.
- Indicators por assessing infant and youg children feeding practice.ISBN (WHO) 978-92-4-001838-9
- www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/pa-2022-documento-tecnico-seguridad-y-soberania-alimentaria.pdf
- Familias, Crianzas y Equipos de salud: Encuentros posibles. Volumen 3. Segundo semestre, etapa de cambios- SAP 2023. ISBN: 978-987-3715-74-7.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados.

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Falso. Quedan exceptuadas la espinaca, acelga, otras verduras de hoja y remolachas hasta los 9 meses por su contenido de nitritos, ya que pueden desencadenar metahemoglobinemia. La introducción de verduras crudas se recomienda a partir de los 12 meses, siempre muy bien lavadas.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. Falso. La que introduce alimentos con mayor cantidad de hierro y energía es BLISS (Baby led introduction to solids).
9. Verdadero.
10. Verdadero.

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

1. GABRIEL, 6 MESES.

A. Evaluaría en Gabriel aspectos madurativos: que haya perdido el reflejo de protrusión lingual, que pueda realizar trípede o mantenerse sentado o erguido con soporte, que tenga posibilidad de tomar alimentos con sus manos, que demuestre interés y curiosidad por el mundo que lo rodea.

B. Las técnicas son complementarias, se pueden ofrecer alimentos de una u otra manera, no hay evidencia científica que demuestre que una sea mejor que la otra. El riesgo de atragantamiento puede existir con cualquiera de las dos, al tratarse de un niño sano, en el caso de que esto sucediera muy posiblemente va a toser y a movilizar el alimento del lugar. Hay que recordar que siempre que se alimenta es necesario la supervisión del adulto. No ofrecer uvas enteras, aceitunas, zanahoria cruda, granos, frutos secos, semillas ni legumbres enteras.

Al comienzo de la alimentación complementaria la indicación es ofrecer variedad en los distintos grupos de alimentos y permitir que explore los mismos. La alimentación en esta etapa hace énfasis en observar la respuesta del lactante ante la incorporación gradual sin forzar. Comerá porciones pequeñas, al inicio sólo 2 o 3 cucharadas.

2. LUNA, 9 MESES

A. Si bien luna recibe lactancia materna y crece bien a esta edad debería comenzar a experimentar con la comida. Presenta maduración acorde y algunos aspectos de lo que relatan son esperables, pero es necesario ofrecer variedad e insistir con los alimentos presentándolos varias veces a fin de que los vaya incorporando.

B. Transmitir que, si bien la alimentación no reemplaza la lactancia, la complementa. Conocer como es la alimentación familiar. Saber si disponen de espacio o donde la realizarían. Explicar que

es necesario tomarse tiempo para la alimentación, que hay que ofrecer distintas presentaciones, mencionar que tenemos que insistir 8 a 10 veces para decir que alguno no le gusta. Ofrecer los distintos grupos de alimentos verduras, frutas, carnes, cereales, legumbres y huevos en diferente presentación. Se puede enriquecer los mismos con aceite oliva, maíz.

C. Si, es necesario que reciba vitamina D 400 U/día y sulfato ferroso 1 mg/kg/día.

3. HELENA, 18 MESES

A. Sería necesario profundizar cómo fue la incorporación de la alimentación complementaria, la aceptación de los distintos grupos de alimentos. ¿Cómo es el momento actual de la comida?

B. Tranquilizaría a los padres explicando que por un lado presenta buena progresión pondoestatural, que la selectividad alimentaria es una característica que los niños pequeños pueden presentar a esta edad, que hay niños y niñas pequeñas que requieren seguir presentándoles los alimentos que empezaron a rechazar, al arrojar alimentos explicarles que eso no debe hacerse o retirar el plato. Si deambula por la casa no seguirla con la cuchara o el tenedor y volver a convocarla a la mesa familiar. No presionar con la cantidad de la ingesta.

C. Desaconsejar cualquier dispositivo electrónico al momento de la ingesta. Remitirse a que se trata de un momento de encuentro familiar y de posibilidad de intercambio.

